

Valutazione neuropsicologica

Sintesi dei risultati

Donato Meoli

Valutazione svolta a Novembre 2024 da una psicologa clinica dell'équipe del dott. Stefano Bramante, psichiatra e specialista di riferimento.

Profilo cognitivo: WAIS-IV

Wechsler Adult Intelligence Scale, quarta edizione (edizione italiana, 2013): i punteggi compositi hanno media 100 e deviazione standard 15.

scala	somma dei punteggi ponderati	punteggio composito	rango percentile	intervallo di confidenza 95%
Comprensione verbale (ICV)	40	123	94	116–128
Ragionamento visuo-percettivo (IRP)	37	113	81	105–119
Memoria di lavoro (IML)	22	103	58	95–111
Velocità di elaborazione (IVE)	22	106	66	98–114
Scala totale (QI)	121	117	87	111–122

Il profilo è disomogeneo: le differenze ICV-IML e ICV-IVE sono significative. La comprensione verbale, nella fascia superiore, è il principale punto di forza, e anche il ragionamento visuo-percettivo si colloca sopra gli indici di efficienza cognitiva (memoria di lavoro e velocità di elaborazione).

ADHD: DIVA-5

Intervista diagnostica per l'ADHD negli adulti, quinta edizione: numero di criteri soddisfatti.

	cut-off	criteri soddisfatti	esito
infanzia, disattenzione	>3	4	presente
infanzia, iperattività/impulsività	>3	1	nella norma
età adulta, disattenzione	>5	7*	presente
età adulta, iperattività/impulsività	>5	1	nella norma

ADHD: BAARS-IV

Barkley Adult ADHD Rating Scale, quarta edizione, compilata da me (self) e da un familiare (other), per l'infanzia e per l'età attuale.

	self, infanzia	self, attuale	other, infanzia	other, attuale
disattenzione	27 (98*)	33 (99*)	28 (98*)	35 (99*)
iperattività/impulsività	13 (51–75)	—	17 (88)	—
impulsività	—	6 (51–75)	—	14 (99*)
iperattività	—	5 (1–50)	—	8 (81)
sluggish cognitive tempo	—	33 (99*)	—	26 (97*)

Punteggio grezzo, con il percentile fra parentesi; in grassetto e con l'asterisco i punteggi patologici.

Conclusioni della relazione

Il quadro emerso dalla valutazione delinea un profilo intellettuale globale medio-alto (QI 117), con significativa disomogeneità interna: punti di forza verbali e visuo-percettivi e relativa fragilità nella memoria di lavoro e nella velocità di elaborazione, associate a difficoltà attentive-esecutive presenti fin dalla prima infanzia. I test effettuati dal paziente (BAARS-IV e DIVA-5) e da un familiare (BAARS-IV other) mostrano risultati positivi sia per l'infanzia sia per l'età adulta; i sintomi caratterizzanti l'età adulta appaiono persistenti e non secondari ad altre condizioni psicopatologiche. Il profilo risulta pertanto compatibile con un quadro di ADHD a prevalenza disattentiva.